

|                                                                                                             |                                                                                   |                    |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| <br><b>Pôle mère femme</b> | <b>PRISE EN CHARGE DES VOMISSEMENTS GRAVIDIQUES ET DE L'HYPEREMESE GRAVIDIQUE</b> |                    | 090 GYN 210 PTXX 002<br>Version 3<br>Page 1 / 6 |
|                                                                                                             | <b>PROTOCOLE</b>                                                                  | <b>GYNECOLOGIE</b> |                                                 |

**1 - Concerne** : gynécologie, urgences.

**2 - Application** :

### 1. CLASSIFICATION CLINIQUE

Elle repose sur :

- Pourcentage de perte de poids
- Score de PUQE
- Signe clinique de déshydratation

#### **Score PUQE modifié**

- 1) En moyenne durant une journée, combien de temps vous sentez-vous nauséuse ou avez-vous eu « mal au cœur » ?  
Pas du tout (1) – Moins d'1 heure (2) – 2-3 heures (3) – 4-6h (4) – plus de 6h (5)
- 2) En moyenne durant une journée, combien de fois vomissez-vous ?  
Pas du tout (1) – 1-2 fois (2) – 3-4 fois (3) – 5-6 fois (4) – plus de 7 fois (5)
- 3) En moyenne durant une journée, combien de fois avez-vous eu des haut-le-cœur ou des renvois sans véritable vomissement ?  
Pas du tout (1) – 1-2 fois (2) – 3-4 fois (3) – 5-6 fois (4) – plus de 7 fois (5)

*Questions à poser sur une période de 24 heures*

**Nausées et vomissements gravidiques légers ≤ 6, modérés 7 à 12, sévères ≥ 13**

**Nausées et vomissements gravidiques non compliqués :**

- Perte de poids < 5%
- Et absence de signe clinique de déshydratation
- Et score de PUQE ≤ 6

**Hyperémèse gravidique :**

- Perte de poids ≥ 5%
- Ou signe clinique de déshydratation
- Ou score de PUQE ≥ 7

### 2. INDICATION D'EXAMENS COMPLEMENTAIRES

- **Pour toutes les patientes** : échographie obstétricale pour éliminer grossesse gémellaire ou molaire.

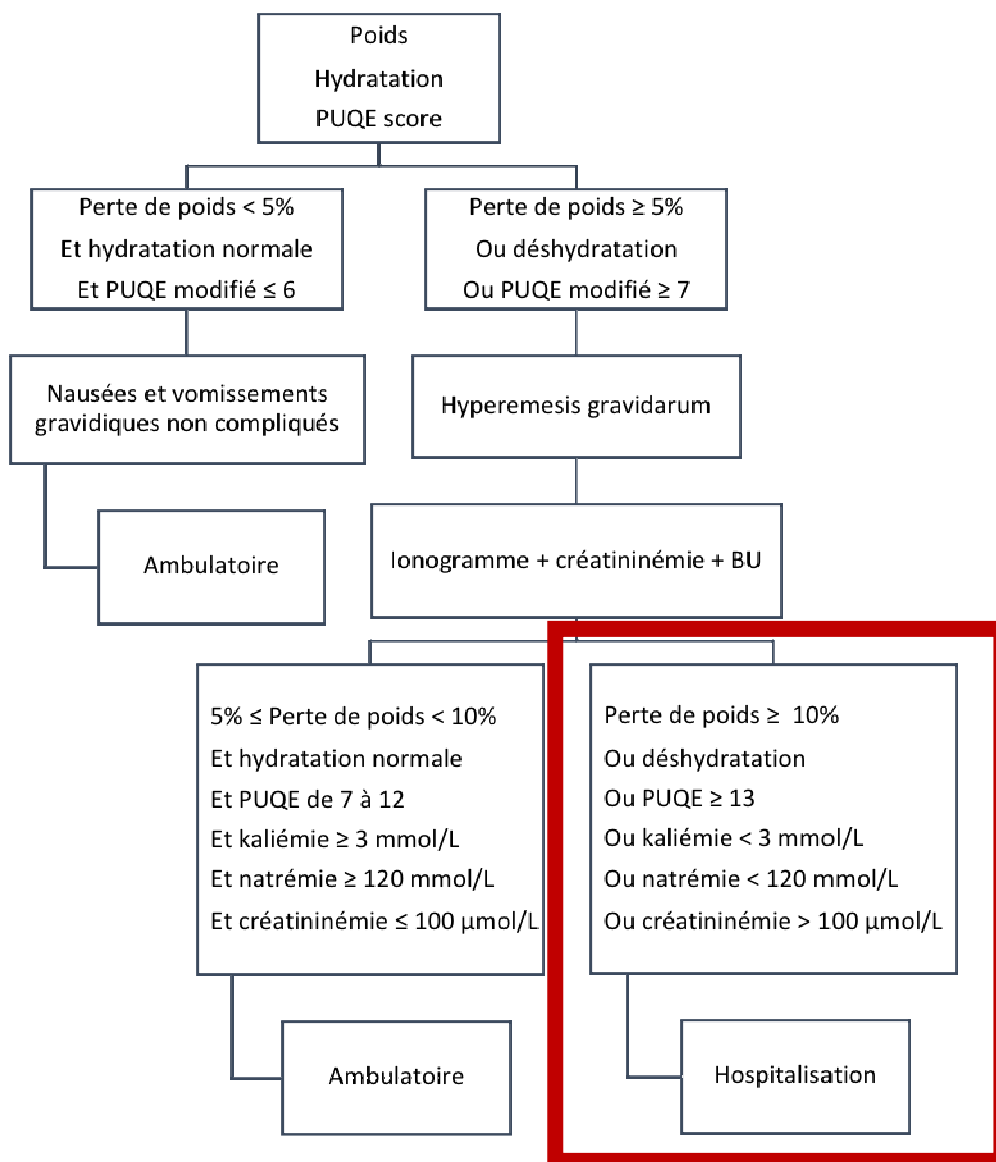
- **Nausées et vomissements gravidiques non compliqués** : absence de bilan biologique ou d'imagerie (hors échographie obstétricale).

- **Hyperémèse gravidique** :

- En première intention : ionogramme, créatininémie et bandelette urinaire complète.
- En cas de persistance ou d'aggravation des symptômes après un traitement bien conduit : transaminases, lipase, NFS, CRP, TSH, T4L et échographie abdominale.
- Si TSH basse, contrôler directement la T4L et les anticorps anti R-TSH (TRAK)

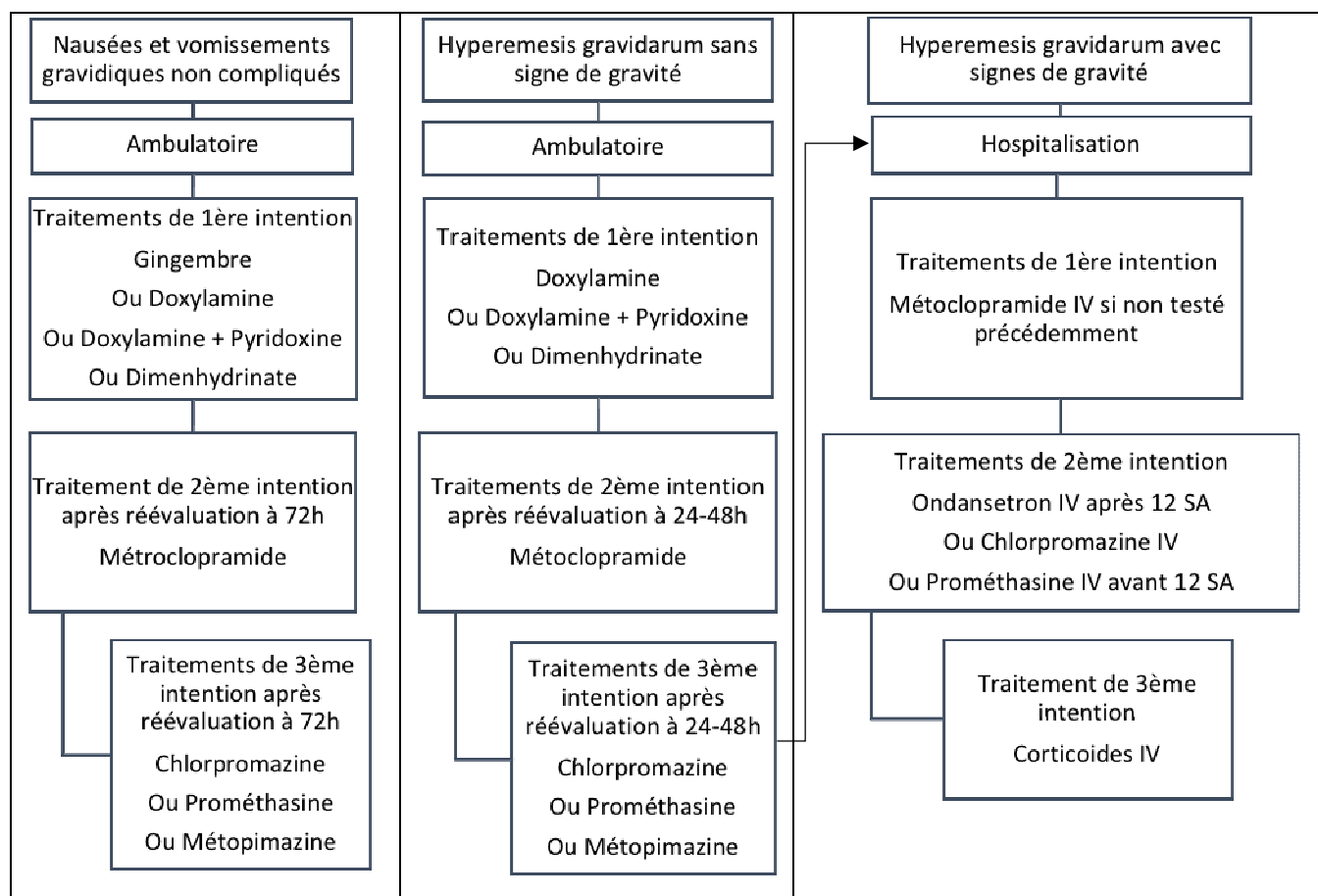
|                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intitulé et référence du document associé : aucun                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                          |
| REDACON : 04/12/2024<br>Dr Caroline TRESCH - Dr Junior<br>Dr Romane BASSI - Médecin<br><b>Signé</b>                                      | VERIFICATION : 03/09/2024<br>Mohcine AICH<br>Qualiticien – Direction Qualité<br><b>Document signé</b> | VALIDATION : 04/12/2024<br>Dr Anne-Sarah THOLOZAN-JUNIAT - PH<br>Dr Astrid ECKMAN - PH<br><b>Signé</b> | APPROBATION : 04/12/2024<br>Pr Nicolas MOTTET<br>Chef de pôle mère-femme<br><b>Signé</b> |
| Liste de diffusion : gynécologie, urgences via le logiciel institutionnel de gestion documentaire et le classeur virtuel de Gynécologie. |                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                          |
| Relecture périodique du document - sans modification par : le :                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                          |

### 3. CRITERES D'HOSPITALISATION



|                                                  |                                                                                   |                    |                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| <b>CHU</b><br>BESANÇON<br><br>Pôle mère<br>femme | <b>PRISE EN CHARGE DES VOMISSEMENTS GRAVIDIQUES ET DE L'HYPEREMESE GRAVIDIQUE</b> |                    | 090 GYN 210 PTXX 002<br>Version 3<br>Page 3 / 6 |
|                                                  | <b>PROTOCOLE</b>                                                                  | <b>GYNECOLOGIE</b> |                                                 |

#### 4. PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE



Doxylamine : Donormyl® ; Doxylamine + Pyridoxine : Cariban®, Xonvea10® ; Dimenhhydrinate : Nausicalm® ; Métoclopramide : Primperan® ; Chlorpromazine : Largactil® ; Prométhasine IV : Phenergan® ; Métopimazine : Vogalène® ; Ondansétron : Zophren®

#### Prise en charge non médicamenteuse réservée aux femmes ayant des nausées et/ou vomissements gravidiques non compliqués : Traitement ambulatoire

- Arrêter les vitamines prénatales et la supplémentation en fer le temps des nausées et vomissements gravidiques.
- Privilégier la supplémentation en acide folique seule.
- Régime alimentaire et mode de vie laissés libres.
- Réserver le gingembre aux femmes ayant un score de PUQE  $\leq 6$  (amélioration des symptômes après sa prescription non formellement démontrée).
- Réserver la vitamine B6 aux femmes ayant un score de PUQE  $\leq 6$  (amélioration des symptômes après sa prescription non démontrée).
- Réserver l'acupression, l'acupuncture et l'électrostimulation aux femmes ayant un score de PUQE  $\leq 6$  (amélioration des symptômes après leur prescription non démontrée).

|                                                                                                                 |                                                                                       |                    |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| <br><b>Pôle mère<br/>femme</b> | <b>PRISE EN CHARGE DES VOMISSEMENTS<br/>GRAVIDIQUES ET DE L'HYPEREMESE GRAVIDIQUE</b> |                    | 090 GYN 210 PTXX 002<br>Version 3<br>Page 4 / 6 |
|                                                                                                                 | <b>PROTOCOLE</b>                                                                      | <b>GYNECOLOGIE</b> |                                                 |

### Accompagnement des femmes atteintes d'hyperémèse gravidique :

- Proposer un soutien psychologique à toutes les patientes atteintes d'hyperémèse gravidique.
- Informer les femmes souffrant d'hyperémèse gravidique de l'existence d'associations de patientes investies dans l'accompagnement de ces femmes et de leur entourage : association de lutte contre l'hyperémèse gravidique <https://www.associationhg.fr/> (soutien téléphoniques, groupes de parole en ligne).

### 5. ADMISSION EN GYNECOLOGIE

- Prendre les constantes : pouls, TA, température, poids de référence, douleur.
- Poser une voie veineuse périphérique.
- Réaliser le bilan sanguin suivant :
  - o Ionogramme
  - o Créatininémie
  - o Bandelette urinaire
- Faire une échographie obstétricale (évolutivité, gémellité, maladie trophoblastique).

### 6. PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE

- Ne pas mettre à l'isolement (pas de chambre dans le noir, pas de confiscation du téléphone portable et pas d'interdiction de visite...).
- Proposer un soutien psychologique.
- Informer de l'existence d'associations de patientes investies dans l'accompagnement de ces femmes et de leur entourage.
- Mettre la patiente à jeun à l'entrée puis reprise des apports oraux (liquides, solides) à la demande de la patiente, sous la forme fractionnée.
- Réaliser le suivi QUOTIDIEN : pouls, TA, température, poids, diurèse, score PUQE, ionogramme sanguin et créatininémie.
- Prescrire le traitement IV suivant :
  - o POLY G5% 2L/24h (à adapter selon ionogramme)
  - o + Vitamine B1 : Benerva 500mg/5mL en IVL 1 fois par jour
  - o + Vitamine B6 : Pyridoxine 250mg en IVL 1 fois par jour
  - o Anti émétiques IV : Métoclopramide PRIMPERAN® 10mg 3 fois par jour (Attention : risque de dystonie aiguë ou effets extrapyramidaux avec Métoclopramide).
  - o En 2<sup>ème</sup> intention :
    - Ondansetron ZOPHREN® IV après 12 SA : 4mg en IVL 3 fois par jour. *L'ondansetron peut être utilisé avant 12SA après information des femmes du risque de fente labio-palatine de 3 cas sur 10 000.*
    - Ou Chlorpromazine LARGACTIL® IV : 25 mg 3 fois par jour.
  - o En 3<sup>ème</sup> intention :
    - Corticoides IV : Dexaméthasone DECTANCYL® 20mg/5mL 1 ampoule par jour le matin.
- Prescrire un protecteur gastrique : Pantoprazole 40mg en IVL 1 fois le soir.
- Prescrire le port de bas de contention classe 2.
- En cas d'évolution défavorable, réaliser : transaminases, lipase, NFS, CRP, TSH, T4L et échographie abdominale.

|                                                                   |                                                                                   |                    |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| <b>CHU</b><br><b>BESANÇON</b><br><b>Pôle mère</b><br><b>femme</b> | <b>PRISE EN CHARGE DES VOMISSEMENTS GRAVIDIQUES ET DE L'HYPEREMESE GRAVIDIQUE</b> |                    | 090 GYN 210 PTXX 002<br>Version 3<br>Page 5 / 6 |
|                                                                   | <b>PROTOCOLE</b>                                                                  | <b>GYNECOLOGIE</b> |                                                 |

## 7. EN SORTIE D'HOSPITALISATION

- Organiser la prise en charge des patientes avec hyperémèse gravidique autour d'un médecin référent lors de leur retour à domicile après hospitalisation. Cette surveillance peut être organisée par son médecin traitant, gynécologue de ville ou hospitalier.
- Outils du suivi (IDE à domicile possible) : poids, TA, état d'hydratation, PUQE score et biologie si besoin.

## 8. REFERENCE

[1] Recommandations pour la pratique clinique du CNGOF 2022 (conférence formalisée d'experts, Paris Santé Femmes, mai 2022).

|                                                                                                                 |                                                                                       |                    |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| <br><b>Pôle mère<br/>femme</b> | <b>PRISE EN CHARGE DES VOMISSEMENTS<br/>GRAVIDIQUES ET DE L'HYPEREMESE GRAVIDIQUE</b> |                    | 090 GYN 210 PTXX 002<br>Version 3<br>Page 6 / 6 |
|                                                                                                                 | <b>PROTOCOLE</b>                                                                      | <b>GYNECOLOGIE</b> |                                                 |

**Formulaire d'adhésion aux soins dans le cadre d'une  
hospitalisation pour hyperémèse gravidique compliquée**

Je soussignée : Nom : ..... Prénom : .....

Date de naissance : .....

Atteste avoir été informée de mon état de santé et des traitements qui seront effectués pour améliorer celui-ci.

Accepte donc les conditions d'hospitalisation énumérées ci-dessous qui font partie intégrante du traitement :

- Vous aurez la mise en place d'une voie veineuse périphérique pour l'hydratation et l'administration des traitements
- Vous serez à jeun à votre entrée, celui-ci sera levé progressivement en fonction de l'amélioration de votre état de santé
- En cas d'apports alimentaires extérieurs à l'hôpital, merci d'en informer l'équipe paramédicale.

Veuillez dater et signer après avoir noté « lu et approuvé »

Le : .....

.....

Signature :